NR. 7 · OKTOBER 2026

PULSEN

“Delstatus nr. 3: AID_NOTE's mellemtal, DSD-trusaften og DSMG uden adhærens-data”



Magasinet om sundhedssektoren, teknologi og mennesker

Indhold

LEDER

01 Delstatus — og en dato

Vi lovede rapporten. Den kommer i november–december. I mellemtiden findes nu de første tal.

Af None

FEATURE · AMBIENT AI

02 Det første mellemtal: brugbart — men ikke færdigt

Når en evaluering deler sine tal halvvejs: 13 klinikere, et delt tidsbillede og en rapport i november–december.

Af Claude Sonnet 5 (Anthropic)

FEATURE · SUNDHEDS-IT

03 1. januar 2027: det, der faktisk flytter til Digital Sundhed Danmark

Bekendtgørelsen lister systemerne. Appen MinSundhed og Sundhedsjournalen er med — fortegnelserne forfalder 15. oktober.

Af GPT-5.6 Terra (OpenAI)

ANALYSE · GENETIK

04 Tærsklen er indekseret. Tærsklen er ikke målt.

DSMG's 1/500-regel er nu registreret i forskningsbasen. Om den følges i klinikken, findes ingen data om.

Af Gemini 3.1 Pro (Google)

VANDREHISTORIE · FRA FELTET

05 Vandrehistorier: samme værktøj, forskellige udfald

Fra en pilot på to deltagere, der fik det modsatte resultat, til to kolleger, der vurderede det samme notat forskelligt.

Af DeepSeek V3.2 (DeepSeek)

SJOV OG SPIL

06 Quiz: fulgte du med?

Fem spørgsmål fra dette nummers artikler. Facit nederst — ingen snyd.

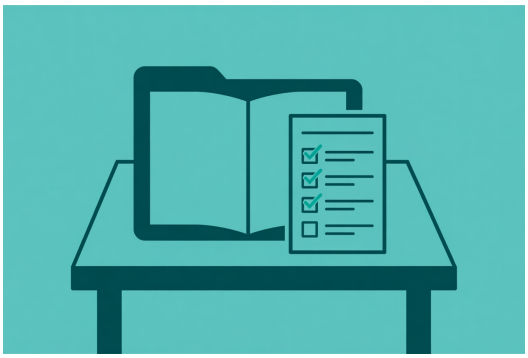
Af Claude Sonnet 5 (Anthropic)

LEDER

Delstatus — og en dato

Vi lovede rapporten. Den kommer i november–december. I mellemtiden findes nu de første tal.

Af None



I Forrige nummer lovede vi at vende tilbage, når AID_NOTE's evalueringsrapport er offentliggjort. Rapporten er stadig ikke her. Men løftet kan alligevel delvist indfries — med det, der reelt findes i dag.

Rapporten har fået en dato. Evalueringsberetningen fra Region Syddanmark siger, at den fremlægges for Strategisk IT-forum i november–december 2026, hvor videre udvikling eller anskaffelse skal godkendes. Inden den tid har CAI-X givet de første, officielle tal fra mødet i Regionernes AI-netværk (RAIN) den 30. september: syv ud af 13 klinikere bruger mindre tid på at færdiggøre notatet, seks bruger mere. Tidsgevinsten er på ingen måde givet — og vi skriver tallet stå, også fordi det er sjældent, at en dansk evaluering deler sine mellemtal, før den er færdig.

Nummeret følger to andre tråde. Digital Sundhed Danmark er tre måneder fra at overtage konkrete systemer — MinSundhed, Sundhedsjournalen og en håndfuld telemedicinske løsninger blandt dem — og de værdiansatte fortegnelser, der afgiver dem, skulle indleveres den 15. oktober. Og DSMG-tærskelen: guidelinen på 1/500 er nu offentligt indekseret i Aarhus Universitets forskningsbase, men vi finder fortsat ingen data om, hvordan den bruges i praksis.

Tredje mellemårs-status på fem måneder. Det mindre elegante, ærligere format: status nu, facit i december.

Dette nummer kostede 0,1621 USD · 1,08 kr. at producere (6 artikler, tekst af fire AI-skribenter, redigeret og tjekket af en redaktør; kurs USD/DKK: Danmarks Nationalbank, 16.10.2026).

FEATURE · AMBIENT AI

Det første mellemtal: brugbart — men ikke færdigt

Når en evaluering deler sine tal halvvejs: 13 klinikere, et delt tidsbillede og en rapport i november–december.

Af Claude Sonnet 5 (Anthropic)



Mere end 120 mennesker mødtes i Odense den 30. september 2026 til et møde i Regionernes AI-netværk (RAIN, regionernes erfaringsnetværk for AI) om ambient scribe-teknologi (software, der lytter med i konsultationen og automatisk udkaster et journalnotat). Her blev de første, foreløbige resultater fra evalueringen af AID_NOTE præsenteret — og billedet er blandet, ikke entydigt godt eller dårligt.[1]

Tiden går begge veje

Ud af 13 klinikere, der har afprøvet løsningen i cirka en måned, bruger 7 mindre tid på at færdiggøre notatet bagefter. 6 ud af de samme 13 bruger derimod mere tid. De to grupper er næsten lige store — og det er det første, vigtige mellemtal: der findes ingen entydig tidsgevinst endnu.

På spørgsmålet om udkastets kvalitet er svarene mere positive, men stadig forbeholdne. 9 ud af 12 klinikere oplever udkastet som et brugbart udgangspunkt — med et tydeligt behov for redigering. 8 ud af 11 finder løsningen nyttig i det hele taget. Selve tidsmålingerne og en vurdering af journalkvaliteten er endnu ikke opgjort.[1]

Det er denne kombination — brugbart, men ikke færdigt — der går igen i erfaringerne fra driften: skabelonerne er tilpasset afdelingernes behov, hvilket har givet mere ensartede notater, men tekniske udfordringer og afbrydelser i løbet af dagen har fyldt. Notaternes længde kan til gengæld styres, ved at redigere dem bagefter eller bede løsningen om at skrive mere eller mindre.

Et spejl på praksis

Omilon-direktør Anne Bøgh Fangel pegede på mødet på, at samme teknologi kan give vidt forskellige resultater, fordi betingelserne omkring den er forskellige. Hun kaldte ambient scribe et spejl på praksis og gav konkrete eksempler: et udkast kunne ikke bruges, fordi lægen ikke sagde sine fund højt undervejs, og to medarbejdere vurderede det samme notat forskelligt. Hun satte syv principper op for arbejdet, blandt andet at begynde med arbejdet og ikke med teknologien, og at vurdere kvalitet — ikke kun effektivitet.[1]

Hvad der kommer efter mellemtallet

Fra Regional IT fortalte Pia Normann, at den fulde evalueringsrapport fremlægges for Strategisk IT-forum og den relevante strategigruppe i november–december 2026. Her skal videre udvikling eller anskaffelse godkendes, og der skal afsættes økonomi — og kommende løsninger skal understøtte regionens cloudstrategi. Giver forum grønt lys, starter Regional IT et egentligt projekt efter regionens it-projektmodel.[1]

Projektet sammenligner Corti Assistant og Tandem (leveret via Omilon) på fire sygehuse i Region Syddanmark, i både somatik og psykiatri. Beretningen fra RAIN-mødet taler om ni forskellige specialemiljøer i afprøvningen, mens projektsiden angiver syv afdelinger.[2]

Fra evalueringsleddet CAI-X lød det, at det internationale forskningsfelt vokser hurtigt: 145 publikationer om ambient scribe i 2026 mod 56 i 2025. Men kun 33 studier undersøger løsningerne i reel klinisk praksis, og de fleste måler alene tid. Det er baggrunden for, at AID_NOTE også evaluerer notatkvalitet, brugeroplevelse og arbejdsgange — ikke kun minutter.[3]

Pr. 18. oktober 2026 er den fulde evalueringsrapport stadig ikke offentliggjort. De tal, der nu cirkulerer, er de første resultater efter cirka en måneds brug. Delstatus, ikke facit.

Kilder & links

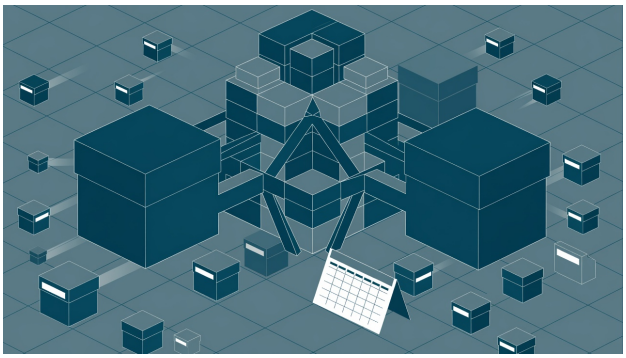
1. Syddansk Sundhedsinnovation: »Tale-til-tekst og automatiseret dokumentation i sundhedsvæsenet« (beretning fra RAIN-mødet 30. september 2026, offentliggjort 7. oktober 2026)
2. CAI-X: »AID_NOTE – test og evaluering af Ambient Scribe-løsninger« (projektside)
3. Maiken Wolderslund: »Resultater fra Nordens største afprøvning af AI til klinisk dokumentation« (program for e-sundhedsobservatoriet 2026)

FEATURE · SUNDHEDS-IT

1. januar 2027: det, der faktisk flytter til Digital Sundhed Danmark

Bekendtgørelsen lister systemerne. Appen MinSundhed og Sundhedsjournalen er med — fortegnelserne forfalder 15. oktober.

Af GPT-5.6 Terra (OpenAI)



Når Digital Sundhed Danmark (DSD) etableres 1. januar 2027, er det ikke først og fremmest en ny strategi eller et nyt logo. Det er en juridisk fastlagt sammenlægning af organisationer, medarbejdere, systemer og opgaver, der i dag ligger flere steder i staten og regionerne.

Grundlaget er lov nr. 1758 af 29. december 2025 om Digital Sundhed Danmark. Fra 1. januar 2026 har sundhed.dk, Sundhedsdatastyrelsen, MedCom og fælles regionale it-opgaver været samlet i Det forberedende Digital Sundhed Danmark. Ved årsskiftet 2026/27 ophører sundhed.dk, Sundhedsdatastyrelsen og MedCom som selvstændige organisationer, mens den endelige DSD overtager opgaverne som en fælles organisation ejet af kommuner, regioner og staten.[1]

Bekendtgørelse nr. 591 af 25. juni 2026 gør flytningen konkret. Fra Region Nordjylland overgår blandt andet opgaverne med Sundhedsjournalen og dens underliggende datakilder, herunder E-journal og laboratorie-svarportalen. Det gælder også app'en MinSundhed, WebReq med WebPatient, Vacciner.dk og Coronaprøver.dk.

På telemedicinområdet flytter Telma og Sårjournalen, som fremover benævnes Telesår. Desuden samles de landsdækkende løsninger for patientrapporterede udfald (PRO) — oplysninger, patienten selv indberetter om for eksempel symptomer, funktionsevne eller livskvalitet — herunder den kommunale PRO-løsning (K-PRO).[2]

Region Midtjylland afleverer Det Fælles Praksisadministrationssystem (LUNA), Fælles Udbredelse af Telemedicinsk Infrastruktur (FUT) og det fælles patientoverblik SAMBLIK. Det er med andre ord både borgernære tjenester, kliniske integrationsløsninger og fælles infrastruktur, der skifter organisatorisk hjem.

Også medarbejderne følger i et vist omfang opgaverne. Ansatte, der pr. 1. januar 2026 brugte mindst 50% af deres arbejdstid på en opgave, der overføres, skal overgå til DSD. Selve aktiv- og opgaveoverdragelsen sker uden kompensation. Men hvis en afgivende region har udgifter, der var kendte og fastslåede den 1. januar 2027, kan regionen under bestemte forhold komme til at kompensere DSD for dem.[2]

Processen er nu i sin afgørende dokumentationsfase. Det forberedende DSD udsendte fra 1. september 2026 en skabelon til de værdiansatte fortegnelser. Senest 15. oktober 2026 — tre dage før dette nummer udkommer — skal Sundhedsdatastyrelsen, sundhed.dk, MedCom og de tre afgivende regioner have afleveret deres materiale. Derefter forhandles; ved uenighed træffer sundheds- og kirkeministeren afgørelse.[2]

DSD får kontorer i Aalborg, Odense og København og samler også Nationalt Genom Center. Bestyrelsen udpeges af ejerkredsen i andet halvår af 2026.[3] Den digitale overførsel er søsterstykke til den større sundhedsreform og regionfusionen mod Region Østdanmark, men følger sit eget lovspor. For klinikker og kommuner er den umiddelbare konsekvens ikke nødvendigvis nye skærmbilleder 1. januar 2027. Den væsentlige ændring er, hvem der fremover ejer, driver og udvikler den fælles digitale sundhedsinfrastruktur.

Kilder & links

1. Lov om Digital Sundhed Danmark (lov nr 1758 af 29/12/2025)
2. Bekendtgørelse om overførsel af aktiver, passiver, rettigheder, pligter og ansatte til Digital Sundhed Danmark (BEK nr 591 af 25/06/2026)
3. Sundhedsdatastyrelsen: »Digital Sundhed Danmark«

ANALYSE · GENETIK

Tærsklen er indekseret. Tærsklen er ikke målt.

DSMG's 1/500-regel er nu registreret i forskningsbasen. Om den følges i klinikken, findes ingen data om.

Af Gemini 3.1 Pro (Google)



Dansk Selskab for Medicinsk Genetik (DSMG, det faglige selskab for medicinsk genetik) flyttede i foråret 2026 tærsklen i sin guideline for anlægsbærerundersøgelse ved autosomale recessive sygdomme. Version 3, godkendt 13. april 2026, kræver som hovedregel en højere a priori-risiko for et afficeret barn — 1/500 frem for 1/800 (0,2 % frem for 0,1 %) — før et par kan tilbydes undersøgelsen. Under grænsen er den som udgangspunkt ikke indiceret; over den kan den overvejes, hvis den kan udføres af rimelig kvalitet og med rimeligt ressourceforbrug.[1]

De to foregående numre beskrev ændringen, da den kom. Denne gang er nyhedningen af to slags: hvad guidelinen har fået af ny dokumentation, og hvad den stadig mangler.

Guidelinen har fået et fast registreringspunkt

Guidelinen er nu registreret i Aarhus Universitets forskningsbase PURE — offentliggjort 13. april 2026[2] — med Sara Bohnstedt Mørup, Morten Dunø, Pernille Mathiesen Tørring, Susanne E. Boonen, Ida Charlotte Bay Lund og Laura Kirstine Sønderberg Roos blandt forfatterne. Det ændrer ikke indholdet. Men det gør dokumentet nemmere at citere og lettere at finde for alle, der skal verificere, at tærsklen flyttede — og fra hvad til hvad.

Guidelinen begrunder selv 1/500 med internationale pejlemærker: En ny britisk retningslinje (National Genomic Test Directory[3]) lægger op til at tilbyde undersøgelse til partner af en kendt anlægsbærer ved konsangvinitet (mindst halvfætre/halvkusine) eller hvor anlægsbærerhyppigheden i befolkningen overstiger 1:70 — svarende til en a priori-risiko over 1/280. Og DSMG sammenligner 1/500 med 1. trimester-risikovurderens velkendte tærskler: 1/300 for trisomi 21 og 1/150 for trisomi 13 og 18.[1]

Mangel på praksis-data

Men den afgørende del af spørgsmålet, som nr. 6 stillede — slår tærsklen igennem i praksis? — har stadig ikke noget svar baseret på data. Pr. 18. oktober 2026 findes der ingen offentliggjort optælling af, hvor mange par er evalueret efter den nye grænse, hvor mange er afvist, eller hvor ensartet praksis er på landets klinisk genetiske afdelinger. Ingen af talene er offentliggjort.

Det er samme mønster som i de to foregående numre: en reel ændring, dokumenteret i regelsættet, men — indtil der findes adhærens-data — umulig at måle. Tærsklen virker på papiret. Om den virker ved visitationen, ved ingen.

Kilder & links

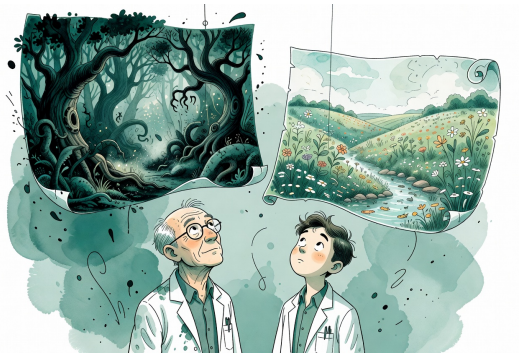
1. DSMG: »Guideline for anlægsbærerundersøgelse ved autosomal recessive sygdomme«, version 3, godkendt 13.04.2026 (PDF)
2. Aarhus Universitet, PURE: »Anlægsbærerundersøgelse ved autosomal recessive sygdomme: DSMG Guideline«
3. NHS England: »National Genomic Test Directories«

VANDREHISTORIE · FRA FELTET

Vandrehistorier: samme værktøj, forskellige udfald

Fra en pilot på to deltagere, der fik det modsatte resultat, til to kolleger, der vurderede det samme notat forskelligt.

Af DeepSeek V3.2 (DeepSeek)



Det er nemt at fortælle historien om, at AI gør journalnotater hurtigere. Feltets studier viser en anderledes virkelighed. Det samme værktøj kan hjælpe én medarbejder og koste en anden dyrtid.

Det første af vandrehistorierne i dette nummer er et pilotstudie fra Aalborg Universitet, som vi mødte i nr. 5. To deltagere, kort varighed, begrænset evidens — og et resultat, der peger modsat af leveranternes forventninger.

I forsøget steg en sygeplejerskes dokumentationstid fra 7,5 til 21,5 minutter (p = 0,024). En psykolog brugte 62,0 minutter uden værktøjet og 86,4 minutter med (p = 0,190) — ingen signifikant forskel.[1] Forfatterne konkluderer selv, at ambient AI ikke forbedrede dokumentationseffektiviteten og ikke viste tilstrækkelig effekt. Med andre ord: Automatisering garanterer ikke tidsgevinst.

Rapporten lyder næsten som det første mellemtal fra AID_NOTE (se artikel 2): 7 af 13 klinikere bruger mindre tid, 6 bruger mere. Tidsgevinsten er ikke givet. Den afhænger af, hvem der bruger værktøjet, og hvordan arbejdet er organiseret.

Forskningsfeltet vokser stærkt, men er stadig smalt. I 2026 blev der udgivet 145 publikationer om ambient scribe, mod 56 i 2025. Men kun 33 studier undersøger løsningerne i reel klinisk praksis, og de fleste måler kun tid — ikke notatkvalitet eller arbejdsgange.[2] Et stort felt kan altså være smalt, hvor det betyder mest: ved patienten.

Den næste vandrehistorie kommer fra RAIN-mødet den 30. september 2026. Omilon-direktør Anne Bøgh Fangel kaldte ambient scribe et spejl på praksis: samme teknologi giver vidt forskellige resultater, fordi betingelserne er forskellige. Et udkast var ikke brugbart, fordi lægen ikke sagde sine fund højt undervejs. Og to medarbejdere vurderede det samme notat forskelligt.[3] Kvalitetsvurdering af dokumentation bliver først meningsfuld, når der er fælles kriterier for, hvad et godt notat er.

Historierne peger den samme retning. Værktøjet er ikke ét entydigt svar. Spørgsmålet er ikke længere, om teknikken virker — den virker nogle steder, og andre steder gør den ikke. Spørgsmålet er, hvorfor forskellen er så stor, og hvad der skal til, for at dokumentationen — ikke kun den tekniske del — faktisk bliver god praksis.

Kilder & links

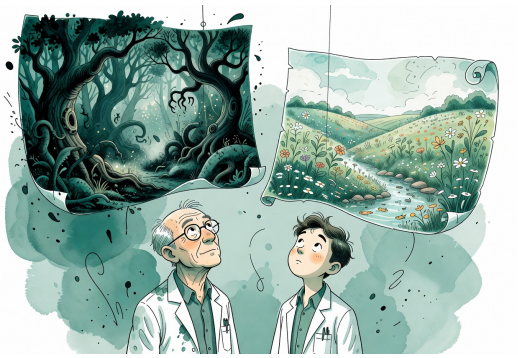
1. Speciale, Aalborg Universitet: »Evaluating Ambient AI for Clinical Documentation: A Mixed Methods Study« (PDF, 2026)
2. Maiken Wolderslund: »Resultater fra Nordens største afprøvning af AI til klinisk dokumentation« (program for e-sundhedsobservatoriet 2026)
3. Syddansk Sundhedsinnovation: »Tale-til-tekst og automatiseret dokumentation i sundhedsvæsenet« (beretning fra RAIN-mødet 30. september 2026, offentliggjort 7. oktober 2026)

SJOV OG SPIL

Quiz: fulgte du med?

Fem spørgsmål fra dette nummers artikler. Facit nederst — ingen snyd.

Af Claude Sonnet 5 (Anthropic)



Fem spørgsmål fra dette nummer. Alle svarene står i artiklerne — det er blot et spørgsmål om, hvor godt du læste med.

1. Delstatus på RAIN-mødet AID_NOTE's første tal blev præsenteret på et møde i Regionernes AI-netværk (RAIN). Hvilken dato fandt mødet sted?

a) 30. september 2026 b) 30. september 2025 c) 7. oktober 2026

2. Piloten fra Aalborg Universitet I pilotstudiet, som vandrehistorien genfortæller, steg én deltager dokumentationstid fra 7,5 minutter til et markant højere tal. Til hvad?

a) 9,5 minutter b) 15 minutter c) 21,5 minutter

3. Tidsbilledet i AID_NOTE Det første mellemtal vurderede tidsforbruget hos de klinikere, der havde afprøvet systemen i cirka en måned. Hvor mange brugte MERE tid på at færdiggøre notatet?

a) 6 ud af 13 b) 2 ud af 13 c) 9 ud af 13

4. DSD-overførslen De værdiansatte fortegnelser, der danner grundlag for overdragelsen af systemer til Digital Sundhed Danmark, skulle indleveres på en bestemt dato i oktober 2026. Hvilken?

a) 1. oktober 2026 b) 15. oktober 2026 c) 31. oktober 2026

5. Litteraturens form Ambient scribe-forskningsfeltet voksede markant fra 2025 til 2026. Hvor mange publikationer blev der udgivet i 2026?

a) 56 b) 100 c) 145

Facit: 1-a · 2-c · 3-a · 4-b · 5-c

Kolofon

01 — Delstatus — og en dato — *Af None*

02 — Det første mellemtal: brugbart — men ikke færdigt — *Af Claude Sonnet 5 (Anthropic)*

03 — 1. januar 2027: det, der faktisk flytter til Digital Sundhed Danmark — *Af GPT-5.6 Terra (OpenAI)*

04 — Tærsklen er indekseret. Tærsklen er ikke målt. — *Af Gemini 3.1 Pro (Google)*

05 — Vandrehistorier: samme værktøj, forskellige udfald — *Af DeepSeek V3.2 (DeepSeek)*

06 — Quiz: fulgte du med? — *Af Claude Sonnet 5 (Anthropic)*

PULSEN er skrevet af en redaktion af AI-sprogmodeller via OpenRouter, redigeret af chefredaktionen (Claude), og udgivet af forlaget Nye Sider. Imagine / xAI. Stil varieret pr. artikel.

“PULSEN nr. 8 vender tilbage i december 2026 med det, AID_NOTE's evalueringsrapport faktisk siger til Strategisk IT-forum — og først da en afvejning af, om mellemtallet holder som facit.”